DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: EDNA PATRICIA VANEGAS **Identificación** CC 66720526
Edad: 54 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	AMI	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA

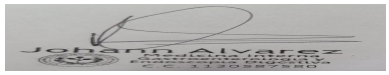
Dx Postoperatorio: K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 13:40:00 **Hora Final** 13:51:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Extensión de sindrome constitucional / TAC sugiere lesión gástrica
ESOFAGO: Normal hasta tercio distal. Cardias franqueable.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico. En cuerpo gastrico distal sobre pared anterior curvatura mayor y pared posteior, se evidencia multiples pliegues gastricos engrosados petreos a la manipulacion, minima distensibilidad, no se evidnecia franca lesion en mucosa. Se evidencia asociado a material quirurgico por ulcera previa perforada. Se toma biopsia sobre biopsia en pliegues para estudio (10 fg). Resto de mucosa corporoantral con algunas erosiones. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
BIOPSIAS: FRASCO 1: Pliegues gastricos engrosados
***CONCLUSION:
1. PLIEGUES GASTRICOS ENGROSADOS A ESTUDIO: linfoma?
2. RAFIA GASTRICA PREVIA
3. GASTRITIS CORPOROANTRAL EROSIVA LEVE
Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐
FRASCO 1: PLIEGUES GASTRICOS ENGROSADOS

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***